晶(平衡盐)2+胶(血浆)1 5%G

举例：一烧伤面积60%、体重50kg病人，第一24小时补液总量为60×50×1.5+2000=6500ml，其中胶体为60×50×0.5=1500ml，晶体(平衡盐)电解质液为60×50×1=3000ml，水分为2000ml，伤后前8小时内输入总量的一半即3250ml，后16小时补入总量的另一半3250ml。第二个24小时，胶体减半为750ml，电解质液减半为1500ml，水分仍为2000ml，于24小时内均匀补入。紧急抢救一时无法获得血浆时，可使用低分子量的血浆代用品，暂时扩张血容量和溶质性利尿，但用量不宜超过1000ml，并尽快以血浆取代。电解质液、胶体和水分应交替输入。

2.急性感染期

①感染性休克是主要死因

此时机体本身处于应激状态，体温本身就会升高

②抗生素、破伤风抗毒素TAT，感染控制后及时停药（不能等体温完全正常）

③早期削痂、切痂、植皮是防治全身感染的关键措施

长期使用广谱抗生素，会导致敏感菌被抑制，不敏感菌↑↑→菌群交替

3.创面修复期、康复期

六、急救和初期治疗

1.转送：建立静脉输液通道、否则口服含盐饮料

2.创面

增加对烧伤深度判断难度

（1）急救现场：减轻疼痛最好是冷疗，疼痛剧烈者可酌情用哌替啶、地西泮。避免用有色药物涂抹

（2）入院后水疱皮内有残存的表皮生发层，可以充当生物敷料，深II度烧伤生发层被烧烂，水疱皮留着会增加感染概率

①**浅II度烧伤保留水疱皮（较大水疱抽去水疱液）**；深II度烧伤去除水疱皮

②敷料内层用油质纱布（防止创面和纱布粘连油-滑）、添加碘伏和磺胺嘧啶银（烧伤继发铜绿假单胞菌感染），外层用吸水敷料（吸收创面渗液）

不好包 包起来会增加感染风险

③包扎范围超出创缘**3-5cm**（我很骚）；会阴、**III度创面**等用暴露疗法 容易导致高渗脱水

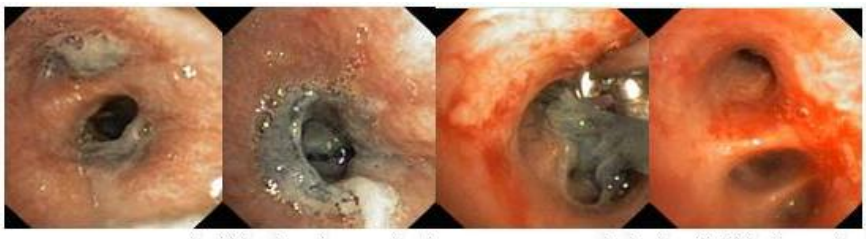
④苯扎溴铵或氯己定消毒创面，不能用酒精（就你笨）

3.吸入性损伤

①**及早气管切开**

②纤支镜（最直接和准确）见气道黏膜炎症反应

③密闭环境、面/颈/前胸部特别是口/鼻烧伤、刺激性咳嗽、痰中有炭屑、声嘶、吞咽困难或疼痛、呼吸困难、哮鸣音，大声呼叫增加吸入性损伤的几率



气道部分阻塞，通气障碍　　清洗后见粘膜损伤严重